

Fecha Última Actualización: 20-01-2023 5:09:38

Página 1 de 3

Información Paciente

Nombre : Maria Consuelo Cayazzo Calabrano
Edad : 58a 1m 18d
Dirección : Eyzaguirre 02070, Interior Psje Esfuerzo 3

Rut : 10.705.230-5
Fecha Nacto: 02/12/1964
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 2225999
Sexo : Femenino
Teléfono : 9 4515 7243

N° Epicrisis
338378

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Medicina Agudos (4tp Piso)

Fecha Ingreso : 28/12/2022 15:40

Días Estadía : 23

Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Egreso : 20/01/2023 05:01

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Falla respiratoria (ingreso a UCI)

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

INGRESO UCI
09/01/2023
María Consuelo Cayazzo Calabrano
10.705.230-5
Familiar: Erika Castillo, hija 946843770

FI HSR: 28/12/22
FI UTIM: 29/12/22
FI UCI: 09/01/2023

Motivo de ingreso a UCI

·Neumonía grave en paciente con neoplasia pulmonar (no clasificada) con fallo orgánico múltiple:

oFalla respiratoria

oFalla hemodinámica

oFalla hematológica / plaquetopenia ¿ anemia

oFalla renal KDIGO 1

oFalla hepática

§Coagulopatía

§Anemización / sangrado digestivo alto

Antecedentes patológicos personales+

·DM2 NIR

·Discopatía degenerativa L5-S1

·Tabaquista 10 cigarrillos por día, niega alcohol y otras drogas.

Historia clínica

Paciente con antecedentes descritos, ingresa al hospital el 28/12/2022 por cuadro clínico caracterizado por somnolencia, coluria y dolor lumbar; refiere que desde hace aproximadamente 3 meses presenta dolor lumbar, baja de peso (aproximadamente 20 kg en 2 meses) sudoración nocturna, compromiso de estado general y anorexia, en ese contexto se había realizado RMN compatible con espondiloartrosis lumbar sin necesidad de resolución quirúrgica.

Fecha Epicrisis : 20/01/2023 05:09

Página 1 de 3

Fecha Última Actualización: 20-01-2023 5:09:38

Página 2 de 3

A su ingreso a la urgencia destaca SatO₂ 82% con FiO₂ 21%, en malas condiciones generales, uso de músculos accesorios de la respiración, fría a distal. sibilancias escasas difusas, abdomen doloroso a la palpación difusa, sin signos de irritación peritoneal, edema bilateral en extremidades inferiores, GSC 14, lenguaje confuso, pupilas isocóricas normorreactivas. EKG: taquicardia sinusal, sin signos de isquemia.

Al laboratorio destaca:

Exámenes de ingreso: K 2.28, BUN 30.5, Crea 0.75, plaquetas 101000, PCR 84.5, INR 1.13, BT 1.91, BD 1.34, FA 280, GGT 1701, GOT 52, GPT 69, lipasa 528, pH 7.522, pCO₂ 40.3, HCO₃ 32.3, Lactato 32.6, sedimento de orina: GB 5-10, GR 0-3, bacterias abundantes. - PCR COVID19 negativa

Se realiza TAC TAP (28/12): Lesión sólida nodular pulmonar peri hilar derecha, de aspecto tumoral. Adenopatías mediastínicas e hiliares, sugerentes de compromiso secundario. Focos de condensación pulmonares bilaterales, probablemente determinados por una neumopatía de etiología inflamatoria - Infecciosa. Impregnación heterogénea seudonodular del parénquima hepático ¿esteatosis? Lesiones focales hepáticas hipo vasculares, sugerentes de compromiso secundario. Colelitiasis. Leve cantidad de líquido libre en la excavación pelviana.

Requiere reanimación con volumen, inicia ceftriaxona, requiere oxígeno suplementario, y se traslada a UTIM.

En UTIM evoluciona con dolor abdominal, descartándose con imagen axial de abdomen pancreatitis, se observan signo se colitis, requirió inicio de ampicilina sulbactam cubriendo dicho foco. Permanece subfebril.

Suma anemia y trombocitopenia progresiva, en ese contexto se realiza 3 angio TC AP (31/12, 04/1 y 09/1) sin sangrado activo o hematomas internos, EDA 05/1 sin lesiones, y, al menos 3 estudios con fibrinógeno que descartan MAT (último de hoy, con FIB >150). Ha requerido soporte transfusional, último 08/1 (1u GR + 6U Plaquetas), además acidosis metabólica.

Con manejo proporcional como consta en evolución (08/01/2023).

En la fecha se reevalúa el caso en contexto de compromiso del sensorio, mala mecánica ventilatoria y fallo orgánico múltiple en paciente con neoplasia sin tipificación se decide manejo activo, por lo que se intuba.

En ese contexto ingresa a UCI.

A su ingreso:

Sedoanalgesia, RASS -2, inicio midazolam y fentanilo hasta RASS -3 como objetivo, pupilas isocóricas, mióticas (puntiformes), areactivas, intubada, se optimiza ventilación mecánica Vc 380 (6.3 ml Kg peso), PEEP 5, FR 24, Ti 0.75. FiO₂ 30%, P mesta 14, PEEP total 6, DP 8, CRO estática 47.5, roncus bilaterales a predominio de base derecha, sibilancias en ambos campos pulmonares, escasos crepitantes en ambas bases, abdomen blando, depresible, excavado, extremidades simétricas, llama la atención lesiones petequiales en torso, abdomen y muslos. En región lumbar úlcera por decúbito grado 3, sangrante. Sarcopenia importante.

Ecocopia, VD menor a VI, buena función de VD, TAPSE superior a 2, no impresiona segmentariedad, VCI 2.3 cm, sin variabilidad. FAST si evidencia de liquido libre en espacio hepatorenal ni esplenorenal.

Planes y problemas

- Hemodinámico. Noradrenalina hasta 0.1 ug Kg min, llenado capilar 2 segundos, parámetros dinámicos negativos para respuesta a volumen.
- Respiratorio. FiO₂ 30%, se optimizó ventilación mecánica, sin conflicto de mecánica respiratoria.
- Hepático. Falla hepática, patrón colestásico, impresiona multifactorial, tanto como parte de su falla orgánica actual como por la presencia de lesiones infiltrantes hepáticas.
- Renal. En falla renal aguda, KDIGO 1, sin urgencia dialítica.
- Infeccioso. VANCO + IMI empírico desde hoy, se aguarda resultado de cultivos.
- En lo oncológico, se aguarda estabilidad para establecer diagnóstico por biopsia, sin embargo mal estado general, fallo orgánico múltiple e infección actual le confieren mal pronóstico a corto plazo.

17/01/2023

Se analiza el caso con jefatura técnica durante visita diurna.

Paciente con poca reserva funcional, cursando falla hepática persistente y falla respiratoria por mecánica ventilatoria fallida caracterizada por esfuerzo inspiratorio alto que no se controla ni con altas dosis de sedación, además falla metabólica con acidosis metabólica persistente. Todo esto en contexto de neoplasia pulmonar no caracterizada con metastasis ganglionares

Fecha Epicrisis : 20/01/2023 05:09

Página 2 de 3

Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



Fecha Última Actualización: 20-01-2023 5:09:38

Página 3 de 3

intratoraxicas y metastasis hepáticas que impresionan ser las responsables de la falla hepática persistente con patron colestásico obstructivo. En manejo porporcional, se establece posibilidad de extubación terminal con medidas de confort y acompañamiento familiar.

En ese contexto en la fecha, aproximadamente a las 18:00 me reuno con la familia y expongo el diagnostico, el pronostico y los posibles desenlaces, se informa sobre la posibilidad de extubación terminal, evaluarán su consentimiento.

Diagnóstico de Egreso

Insuficiencia hepática aguda - Obs neo pulmón

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Pcte con falla respiratoria severa en contexto prob neoplasia de pulmón con MTT hepática

Plan Post Alta

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente



Carolina Ruiz Balart

Médico Tratante (Staff)